

Fecha Última Actualización: 01-03-2023 19:47:41

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Patricia Antonia Figueroa Barros
Edad : 25a 2m 16d
Dirección : Pje Estero Del Arrayan 0842 0842

Rut : 19.882.273-6
Fecha Nacto: 13/12/1997
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1111939
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 9059 2193

N° Epicrisis
343514

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 25/02/2023 05:25

Días Estadía : 4

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 01/03/2023 19:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

TOs y dificultad respiratoria

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS

Nombre: Patricia Figueroa Barros
Edad: 25 años
RUT: 19.882.273-6
FI CASR: 25.03.2023
FI UCI: 25.02.2023

Antecedentes:
Vitiligo desde la infancia

Historia:

Pcte con antecedentes descritos. Historia de 1 mes d eevolución tos seca persistenite,a sociado a expectoración mucopurulenta, que se acompaña de dolor toracico tipo puntada en costado izquierdo, sensación febril intermitente, CEG y bja de peso de aproximadamente 5kg. Multiles consultas en extrasistema, completando tratamientos ATB con Amoxicilina, Amoxicilina/Ac. Clavulánico, Azitromicina.

Dado persistenica de síntomas, consulta en UEA CASR.

Ecoscopia pulmonar con lesión de 3x4 cms tercio medio y patrón de condensación en base izquierda.

Se realiza TC Torax: voluminosa lesión cavitada en LII, focos de bronquiolitis bilat, origen inflamatorio infeccioso.

Evoluciona en regulares condiciones, taquicardica y peaks febriles. GeneXpert (+) para M. tuberculosis, tomado en urgencia, por lo que inicia en Urgencia terapia antiTBC.

Cae en insuficiencia respiratoria con polipnea hasta 40rpm, por lo que se intuba.
Se decide traslado a UCI para continuar manejo

Diagnósticos de Ingreso
Insuficiencia Respiratoria Aguda
SDRA
NAC atípica + TBC

Fecha Epicrisis : 01/03/2023 19:47

Página 1 de 4

PLANES Y PROBLEMAS UCI:

1. HDN y CV: HCT: 33 / Hb: 10,4 / Lactato: 14,7 / 1,6 ml/L.

Se mantiene Muy Grave . Con necesidad de DVA para mantener PAM > 65. Con dosis moderadas a altas de NAD : 0,2 ug/kg/h. y con Adrenalina: 0,12. Con aceptable llene capilar. Arritmias: taquicardia sinusal.. Sin necesidad de transfusión de GR.

PLANES: Mantengo indicaciones. Se mantiene en observación. Evaluar cambio o suspensión de adrenalina.

2. RESPIRATORIO: PaFiO2: 192,8 . / pH: 7,23 . / PaCO2: 37,7 . / Bic: 15,7. Dje Pleural Dº: No. Dje Pleural Iº: No.

Hoy 3 ° día en VMI, en A/C x vol con flujo cuadrado, con Vt: 330 (6,3 ml/kg) x 30 . Vol/min: 9.9 . Pmeseta: 23 . PEEP: 10 . T insp: 0,6 . Flujo: 34 . DP: 13 . y Distensibilidad: 25,8 . IOX: 8,3. Resistencia: 19. Energía Mecánica: 19,8 J/min. Se mantiene muy grave, en regulares condiciones. Con regular mecánica ventilatoria y regular intercambio gaseoso. Sin posibilidad de weaning por el momento.

PLANES: Por ahora sin cambios.

3. NEUROLOGICO: Con sedoanalgesia y con RNM. SAS: 1 y Glasgow: 3

Grave, con Fentanyl 180 ug/h (3 ug/kg/h), Midazolam 12 mg/h (0,2 mg/kg/h), y Vecuronio 3 mg/h (0,05 mg/kg/h)

PLAN: Por ahora sin cambios.

4. INFECCIOSO: Grave. Estable. PCR: N/E <¿ 307,7 <¿ 304,7 / Leu: 20.520 <¿ 14.950. / Procalcitonina: N/E

2 ° día ATB: Imipenem y Tto anti TBC.

? / Cultivos. / Resultado

Muy Grave, ayer y hoy destaca Febril. Con PCR muy alta estacionaria, y Leucocitos muy altos en aumento. Se revisarán cultivos para ver necesidad de ajuste ATB. En caso de Tº > 38°C : ¿> pancultivar.

PLANES: Lo ya señalado. Se mantiene en observación.

5. RENAL: Diu: 1.810 cc/24h. / 75,4 cc/h. / 1,26 cc/kg/h. Crea: 2,54 / BUN: 28,5. Clearance Crea: 32 mL/min./ BH ayer: /BH acum: N/Ecc

Grave, con diuresis aceptable y función renal inestable en falla renal aguda. Na: 146 / K: 4,94 / Cl: 123 / Ca: 8,2 (No Corregido por albúmina) Cai: N/E / P: 4,7 / Mg: 3,2

PLANES: Se mantienen indicaciones. Evitar nefrotóxicos.

6. NUTRICIÓN Y METABOLISMO: Residuo Gástrico: N/E cc / Deposiciones: 0 cc / Req Insulina: 0 UI. Glicemia: 123

Grave. Con Fresubin a 40 cc/h x SNG, pero en stand by. Actualmente con SG 20%. a 20cc/h. . Con buen mal regular control metabólico.

PLANES: Por ahora mantengo indicaciones.

7. DIGESTIVO Y HEPATICO: BiliT/D: N/E FA: N/E GGT:N/E SGOT: N/E SGPT: N/E

Hoy no controlado. Sin cambios.

PLANES: Control cada 72 hrs.

8. COAGULACIÓN Y PLAQUETAS: INR: N/E Plaquetas: 419.000

Sin urgencia transfusional. Se mantiene en observación.

PLANES: Lo señalado.

9. QX: Sin urgencia Qx.

PLANES: Lo señalado.

10. PROFILAXIS Y ULCERAS: Profilaxis gástrica : Si / Profilaxis TVP: No (OJO) / UPP: N/E

PLANES: Sin cambios.

HOY 01/03/2023

Fecha Epicrisis : 01/03/2023 19:47

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 01-03-2023 19:47:41

Página 3 de 4

(Registro 16:50 hrs)

Nombre: PATRICIA ANTONIA FIGUEROA BARROS Edad: 25 Años

4 ° día Hospitalizado

3 ° día UCI

4 ° día VMI

4 ° día CVC Yugular Ant D°

3 ° día ATB: IMipenem + tto AntiTBC

Diagnósticos:

1. Insuficiencia Respiratoria Aguda hipoxémica

2. Tuberculosis Pulmonar Activa

-> Cavitación son sospecha de sobreinfección Obs Aspergillus

3. Shock Cadiogénico

-> Sospecha de Miocarditis Fulminante Infecciosa (Obs TBC) Vs TEP Masivo

4. Cetoacidosis Diabética en resolución

5. Injuria Renal Aguda KDIGO III

Se recibe AM a paciente en estado de gravedad, en supino, en SAS 1 con sedación fentanyl 3 ug/kg/hr + Midazolam 0.15 mg/kg/hr, con requerimiento de DVA en dosis elevadas (BIC Noradrenalina a 0.17 mcg/kg/min). Además, con vecuronio a 3 mg/hr. Con buena sincronía a VMI en modo A/C volumen VT 320 con PEEP de 8 FIO2 55%con PAFI de control AM de 164.

Dentro de la mañana, se realiza lavado broncoalveolar con plan de objetivar microorganismo causante de sobreinfección pulmonar enviándose muestras a cultivos y a estudio molecular ampliado con resultado que informó film array negativo.

Sin embargo, la paciente evolucionó con mayor compromiso oxigenativo y en su macrohemodinamia, con marcada taquicardia (FC promedio sobre 160). Se realiza eco bedside y se objetiva contractilidad disminuida con VTI cercano a 8 y bajo GC, por lo que se agrega adrenalina para favorecer inotropismo con respuesta parcial

Posteriormente se toma la decisión de realizar estudio imagenológico para esclarecer causa de falla respiratoria catastrófica en curso, y luego instalar monitor avanzado de gasto cardíaco y pronó.

A las 15 hrs aproximadamente se llevó a paciente a sector de imagenología, donde sufre paro cardiorrespiratorio, que se realiza maniobras de reanimación avanzada durante 1 hora aproximadamente en rayos, y luego se llevó a UCI donde se continuaron maniobras de reanimación por 19 minutos, saliendo en múltiples ocasiones de asistolia a TV y FV, sin respuesta a maniobras.

Se declara hora de fallecimiento a las 16.47 hrs. Se entrega certificado de defunción a familiares.

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia Respiratoria aguda - 1. Insuficiencia Respiratoria Aguda hipoxémica

2. Tuberculosis Pulmonar Activa

-> Cavitación son sospecha de sobreinfección Obs Aspergillus

3. Shock Cadiogénico

-> Sospecha de Miocarditis Fulminante Infecciosa (Obs TBC) Vs TEP Masivo

4. Cetoacidosis Diabética en resolución

5. Injuria Renal Aguda KDIGO III

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

HOra de muerte: 16: 47 horas

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Fecha Epicrisis : 01/03/2023 19:47

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:59

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 01-03-2023 19:47:41

Página 4 de 4

Controles

INTERNO

Becado/Residente

John Gutierrez González

Médico Tratante (Staff)